

Первая помощь при кровотечениях: алгоритмы действий и виды кровопотери

[Главная](#) — [Статьи](#) — Первая помощь при кровотечениях: алгоритмы действий и виды кровопотери



Дата публикации: 12.04.2026

Вызов
скорой



Автор статьи

Морозова Екатерина Андреевна

Должность

Фельдшер

Квалификационная категория

Первая

Стаж работы по специальности

Общий медицинский стаж 6 лет. В компании МосМедТранс с 2019 года.

Кровотечение - это всегда экстренная ситуация, требующая мгновенной реакции. От того, насколько быстро и грамотно будут оказаны первые действия, напрямую зависит не только здоровье, но и жизнь человека. В медицине существует понятие «золотого часа» - времени, в течение которого пострадавший должен получить помощь, чтобы шансы на выживание и благоприятный исход были максимальными.

Однако, чтобы помощь была эффективной, а не вредной, важно понимать, что кровотечения бывают разными. Универсального метода остановки крови не существует: то, что спасает при порезе пальца, смертельно опасно при ранении крупной артерии. Поэтому первый и самый важный шаг - определить тип поврежденного сосуда и характер кровотечения, чтобы выбрать верный алгоритм действий.

В этой статье мы подробно разберем все виды кровопотери, симптомы, по которым их можно распознать, и пошаговые инструкции по оказанию первой помощи - от простых капиллярных до жизнеугрожающих внутренних и артериальных кровотечений.

Фонет
скорой

Классификация кровотечений: как распознать и не ошибиться

Когда случается беда, вокруг раненого начинается суеда. Кто-то кричит "жгут!", кто-то пытается промывать рану водой. Чтобы не навредить, нужно за пять секунд понять природу повреждения. В медицине разработана четкая система классификации, которая помогает даже неспециалисту сориентироваться и выбрать верную тактику спасения.

Почему это так критично? Потому что методы остановки крови диаметрально противоположны. То, что эффективно при повреждении мелких сосудов, бесполезно, а порой и смертельно опасно при ранении артерии. Поэтому ваша первая задача - провести быструю диагностику по трем основным параметрам.

Что течет: разбираемся в типах сосудов

От того, какой именно сосуд пострадал, зависит интенсивность кровопотери и способ ее купирования.

Артериальное - бьет ключом. Это самая грозная ситуация. Кровь алая, яркая, как краска, потому что насыщена кислородом. Она выбрасывается из раны толчками, синхронными пульсу, а при повреждении крупного ствола бьет настоящим фонтаном. Давление в артериях огромно, поэтому кровь вылетает под напором. Если вовремя не пережать сосуд, человек потеряет сознание за пару минут.

Венозное - льется рекой. Здесь картина иная. Кровь темная, густая, напоминает цвет вишневого компота, так как она уже отдала кислород тканям и течет обратно к сердцу. Из раны она вытекает равномерно, без пульсации, но очень обильно. Опасность в том, что при ранении крупных вен (особенно на шее) туда может засосаться воздух, что приведет к мгновенной смерти от воздушной пробки.

Капиллярное - сочится росой. Возникает при ссадинах, царапинах, поверхностных порезах. Кровь выступает мелкими капельками по всей поверхности раны, как вода из губки. ^{Вызов} ~~Крупные~~ ^{сосуды} ~~сосуды~~ не задеты, поэтому угрозы для жизни обычно нет, если у человека нормальная свертываемость.

Паренхиматозное - "плачущие" органы. Это отдельный вид внутреннего кровотечения, о котором полезно знать. Речь идет о повреждении внутренних органов - печени, селезенки, почек. Их ткань (паренхима) пронизана сетью сосудов настолько плотно, что остановить такое кровотечение без операции невозможно. Кровь сочится со

всей поверхности органа, и домашними методами здесь не помочь - только срочная операционная.

Куда уходит кровь: наружу или внутрь

Это второй важнейший признак, влияющий на тактику первой помощи.

Наружное кровотечение. Все просто: есть рана, и вы видите, как кровь покидает тело. Это может быть глубокая рана на ноге или банальное носовое кровотечение. Диагностика не требует специальных навыков.

Внутреннее кровотечение. Настоящий "невидимый убийца". Кровь изливается внутрь тела - в живот, грудь, полость черепа или в полый орган (например, желудок). Снаружи ничего не видно, а человек тем временем угасает. Заподозрить беду можно по косвенным признакам: кожа становится бледной и липкой от холодного пота, пульс учащается, но слабеет, давление падает, кружится голова, наваливается неодолимая слабость. Любое подозрение на внутреннее кровотечение требует немедленной госпитализации.

Когда случилось: первичное и вторичное

Эта классификация важна скорее для врачей, но и обычному человеку стоит о ней знать.

Первичные. Кровь пошла сразу в момент травмы. Это классическая ситуация, описанная выше.

Вторичные. Кошмар хирургов. Кровотечение открывается спустя часы или даже дни после травмы или операции. Причина - либо нагноение раны (гной просто "съедает" тромб), либо соскальзывание нитки, которой перевязали сосуд. Это всегда неожиданность, требующая экстренного вмешательства.



Вызов
скорой



Алгоритм оказания первой помощи при наружных кровотечениях

Вызов
скорой

До того как приступить к непосредственной остановке крови, необходимо быстро оценить обстановку и состояние пострадавшего. Действуйте по четкой схеме, не поддаваясь панике.

Универсальный протокол первых секунд:

1. **Обеспечьте безопасность.** Осмотритесь вокруг. Если источник опасности не устранен (например, оголенные провода, огонь, угроза обрушения или интенсивное дорожное движение), сначала устраните угрозу или, если это невозможно, аккуратно переместите пострадавшего в безопасную зону. Защита собственной жизни - приоритет.
2. **Быстрая диагностика.** Оцените, находится ли человек в сознании, есть ли у него пульс на сонной артерии (для этого приложите пальцы к шее сбоку от кадыка) и дышит ли он. Если дыхание отсутствует, а пульс не прощупывается, времени на раздумья нет - начинайте сердечно-легочную реанимацию (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание). Если пульс есть, переходите к следующему шагу.
3. **Сигнал бедствия.** Незамедлительно свяжитесь со службой спасения по номеру 103 или 112. Если вы не один, громко прикажите кому-то из окружающих вызвать медиков. Говорите четко: сообщите, что именно произошло, каков характер кровотечения (струей, пульсирует или просто сочится) и в каком состоянии находится пострадавший.
4. **Выбор тактики.** В зависимости от того, какой сосуд поврежден, применяйте один из методов остановки крови, описанных ниже.

Как помочь при капиллярном кровотечении

Самый легкий случай - повреждены лишь мельчайшие сосуды. Обычно такая кровопотеря не угрожает жизни, но требует правильной обработки, чтобы избежать заражения.

Ваши шаги:

1. Очистите поврежденный участок от видимых загрязнений. Используйте для этого проточную воду, если ее нет - влажные салфетки или чистую ткань.
2. Продезинфицируйте края ранки (именно края, а не внутреннюю поверхность). Подойдет перекись водорода, раствор Хлоргексидина или слабый раствор марганцовки. Помните: спиртосодержащие жидкости (водка, одеколон) **усиливают** боль и **могут** травмировать открытые ткани, замедляя заживление.
3. Наложите стерильную салфетку и зафиксируйте ее бинтом. Повязка должна быть умеренно тугой, чтобы остановить кровь, но не передавливать окружающие ткани.

Когда пора в больницу:

Кровь никак не желает останавливаться дольше четверти часа.

В ранке видны инородные частицы, которые вы не можете извлечь самостоятельно.

Травма получена от ржавого металла или загрязненного землей предмета (понадобится прививка от столбняка).

У пострадавшего есть заболевания крови (гемофилия) или он принимает антикоагулянты (препараты, снижающие свертываемость).

Техника остановки венозного кровотечения

Распознать его легко: кровь имеет густой вишневый оттенок и вытекает равномерно, без толчков. Основная угроза здесь - значительная потеря объема крови, а при ранении шейных вен - засасывание пузырьков воздуха в сосуд (воздушная эмболия).

Правильная техника:

1. **Давящая повязка - главный инструмент.** Забудьте про жгут в данном случае, он только навредит, усилив венозный застой.
2. Возьмите стерильную марлевую салфетку (или чистую хлопчатобумажную ткань), покройте ею рану. Сверху положите плотный валик - например, туго скрученный бинт или носовой платок.
3. Этот валик нужно сильно прижать к ране и примотать бинтом так, чтобы он оказывал постоянное давление на поврежденный сосуд. Вы должны увидеть, что кровотечение остановилось или стало значительно слабее.
4. **Важный нюанс:** поврежденную руку или ногу обязательно поднимите выше уровня сердца - это уменьшит приток крови к месту травмы.

Шея - особый случай: Если кровоточит крупная вена на шее, повязку накладывают иначе. Чтобы не пережать дыхательные пути и не нарушить кровоток в противоположной артерии, со здоровой стороны руки заводят за голову и прибинтовывают повязку через нее как через импровизированный каркас.

Вызов
скорой



Экстренные меры при артериальном кровотечении

Это самый драматичный и опасный сценарий. Алая кровь вырывается наружу мощными толчками, синхронными с ударами сердца. Счет идет на секунды - человек может потерять сознание от массивной кровопотери за считанные минуты.

Пальцевое прижатие - ваш экстренный тормоз.

Не тратьте время на поиски жгута, если кровь хлещет фонтаном. Немедленно надавите пальцем или кулаком на артерию выше места повреждения, прижимая ее к кости. Это позволит выиграть 5-10 минут для подготовки жгута.

Куда давить:

Шея (сонная артерия): Прижмите пальцами к позвоночнику сбоку от трахеи.

Плечо (плечевая артерия): Зажмите сосуд с внутренней стороны плеча в мышечной борозде, прижимая к кости.

Бедро (бедренная артерия): Это мощнейший сосуд. Прижимать нужно кулаком, сильно надавливая в паховой области к лобковой кости.

Подмышка (подмышечная артерия): Обхватите плечо пострадавшего, сдавите пальцами артерию глубоко в подмышечной впадине.

Жгут: инструкция по применению.

Жгут накладывают строго выше раны, ближе к туловищу. Использовать его нужно только при артериальном кровотечении, когда пальцевое прижатие временно остановит кровь.

Золотые правила:

Вызов
скорой

Никогда не накладывайте резину на голое тело - подложите под жгут ткань, бинт или часть одежды пострадавшего.

Первый виток (тур) делайте самым тугим, чтобы остановить кровь. Последующие витки - чуть слабее, для фиксации.



Контроль времени - критически важен! Запишите время наложения на бумаге и положите записку под жгут. Если бумаги нет, напишите шариковой ручкой прямо на лбу пострадавшего или на видном месте конечности.

Летом жгут может оставаться на теле до 60 минут, зимой (из-за риска обморожения) - не более 30 минут.

Если за это время не удалось доставить пострадавшего в больницу, осторожно ослабьте жгут на 5-10 минут, предварительно прижав артерию пальцем, затем затяните вновь, но уже чуть выше предыдущего места.

После наложения жгута конечность следует обездвижить (наложить шину) и в холодное время года тщательно укутать, чтобы защитить от мороза.

Вызов
скорой



Скорая помощь при внутреннем кровотечении (Догоспитальный этап)

Вызов
скорой

Внутреннее кровотечение - наиболее коварный вид кровопотери. Его сложно распознать вовремя, так как кровь не вытекает наружу, а скапливается внутри организма. Без своевременной помощи оно быстро приводит к геморрагическому шоку и летальному исходу. Заподозрить внутреннее кровотечение можно только по косвенным признакам.

Симптомы внутреннего кровотечения (запомните их!):

Общие признаки: Резкая слабость, сонливость, головокружение, потемнение в глазах, «мушки» перед глазами. Пострадавший может жаловаться на сильную жажду.

Внешний вид: Резкая бледность кожи и видимых слизистых оболочек, холодный липкий пот.

Пульс и давление: Пульс становится частым, слабым, нитевидным (тахикардия), артериальное давление падает.

Специфические признаки (зависят от локализации):

Легочное кровотечение: Кашель с ярко-алой пенистой мокротой.

Желудочное кровотечение: Рвота цвета "кофейной гущи" (кровь, вступившая в реакцию с соляной кислотой).

Кишечное кровотечение: Дегтеобразный черный стул (мелена).

Кровотечение в брюшную полость: Вздутие живота, боль при пальпации, напряжение мышц передней брюшной стенки.

Алгоритм действий при подозрении на внутреннее кровотечение:

1. **Немедленный вызов скорой помощи.** Сообщите диспетчеру, что подозреваете внутреннее кровотечение, и назовите предполагаемую область (живот, грудь).

2. **Придание правильного положения:**

Уложите пострадавшего на спину.

При отсутствии травмы головы приподнимите ноги (валик под ноги) - это обеспечит приток крови к головному мозгу и предотвратит потерю сознания.

При подозрении на легочное кровотечение придайте полусидячее положение, чтобы облегчить дыхание.

3. **Холод на предполагаемую область:**

Вызов
скорой

Приложите пузырь со льдом, бутылку с холодной водой или любой холодный предмет к животу, груди или другой области, где предположительно идет кровотечение.

Держите холод по 15-20 минут с перерывами, чтобы не вызвать обморожение. Холод вызывает спазм сосудов и может немного замедлить кровопотерю.

4. Категорически запрещено:

Ни в коем случае не давать пострадавшему есть и пить! Жидкость и пища усиливают перистальтику и могут ускорить кровотечение. К тому же, может потребоваться экстренная операция под наркозом, а полный желудок - это риск аспирации.

Не давать обезболивающие (они могут смазать клиническую картину и затруднить диагностику врачам).

Не прикладывать грелку.

Не промывать желудок и не ставить клизмы.

5. Транспортировка:

Если скорая задерживается, а состояние критическое, транспортировать пострадавшего нужно в положении лежа на носилках, максимально бережно, избегая тряски.

Внутреннее кровотечение не лечится в домашних условиях или в машине скорой помощи. Остановить его можно только в операционной. Поэтому главная задача окружающих - как можно быстрее доставить пострадавшего в стационар или передать бригаде медиков.

Особенности первой помощи при некоторых видах кровотечений

Универсальные правила работают не всегда. Носовое, маточное или желудочное кровотечение требуют особого подхода. Рассмотрим алгоритмы действий в этих ситуациях.

Неотложная помощь при носовом кровотечении

Носовое ^{Вызов}кровотечение (эпистаксис) может возникнуть из-за травмы, перепада давления, перегрева или при резком движении. Хотя чаще всего оно останавливается самостоятельно, иногда требуется помощь.

Правильные действия:

1. **Положение:** Усадите пострадавшего, слегка наклонив голову вперед. Это самый важный момент! Кровь должна вытекать наружу, а не стекать в глотку.
2. **Механическое сдавливание:** Плотно прижмите крылья носа пальцами к носовой перегородке и держите 5-10 минут. Обычно этого времени достаточно для образования тромба.
3. **Холод:** Приложите холод (лед, бутылку с холодной водой, замороженный продукт, завернутый в ткань) к переносице или затылку. Холод способствует рефлекторному сужению сосудов.
4. **Тампонада:** Если простого прижатия недостаточно, можно ввести в носовой ход ватный или марлевый тампон, смоченный в перекиси водорода или сосудосуживающих каплях (например, Нафтизин), оставив кончик тампона снаружи для извлечения.

Чего делать категорически нельзя:

Запрокидывать голову. Это распространенное заблуждение может стоить здоровья. В таком положении кровь не останавливается, а просто меняет направление - начинает стекать по задней стенке глотки в пищевод и дальше, в желудок. Вы теряете контроль над ситуацией, не видите истинного объема кровопотери. Более того, это часто провоцирует рвоту свернувшейся кровью, а в самых тяжелых случаях жидкость может попасть в трахею и бронхи, вызвав удушье.

Высмаркиваться. Резкие движения и создаваемое при этом давление внутри носа разрушают естественный "защитный тромб", который только начал формироваться. В результате кровотечение открывается с новой силой, и все усилия идут насмарку.

Когда без визита к врачу не обойтись:

Кровь продолжает идти дольше 20 минут, несмотря на все попытки ее остановить.

Травма носа произошла в результате сильного удара по голове (особенно если был ушиб головы или потеря сознания).

Потеря крови настолько интенсивна, что человек начинает чувствовать сильную слабость, **кружится** голова или наступает обморочное состояние.

Кровотечение сопровождается сильной головной болью, "мушками" перед глазами или ухудшением зрения.

Первая помощь при маточном кровотечении

Маточное кровотечение может возникнуть по разным причинам: гормональный сбой, воспалительные заболевания, миома, стресс или патологии беременности. Оно опасно быстрой и обильной кровопотерей.

Действия:

1. **Вызов скорой помощи.** При обильном кровотечении (несколько прокладок в час) необходима срочная госпитализация.
2. **Горизонтальное положение.** Уложите женщину на спину, на ровную жесткую поверхность. Ноги лучше приподнять (валик под ноги), чтобы обеспечить приток крови к жизненно важным органам.
3. **Холод на низ живота.** Положите пузырь со льдом или грелку с холодной водой на живот (ниже пупка) на 15-20 минут с перерывами. Холод сужает сосуды матки.
4. **Восполнение жидкости.** Если женщина в сознании и нет подозрения на внутреннюю патологию, требующую операции, давайте обильное питье (сладкий чай, вода), чтобы восполнить потерю жидкости.
5. **Сбор информации.** Постарайтесь выяснить, есть ли у женщины беременность (в том числе внематочная), так как это требует совершенно разных протоколов лечения.

Категорически запрещено:

Принимать горячую ванну, ставить грелку на живот.

Спринцеваться.

Принимать любые лекарства без назначения врача (особенно Аспирин, который разжижает кровь).

Ждать, что "само пройдет", если кровотечение усиливается.

Действия при желудочно-кишечном кровотечении

Вызов
скорой



Желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК) - это внутреннее кровотечение в просвет пищевода, желудка или кишечника. Чаще всего возникает из-за язвы, эрозии, варикозного расширения вен пищевода или онкологии.

Распознаем симптомы:

Рвота "кофейной гущей" (темно-коричневая масса).

Рвота алой кровью (при массивном кровотечении из пищевода).

Черный, дегтеобразный стул (мелена). Обратите внимание: черный стул появляется не сразу, а через несколько часов после начала кровотечения.

Слабость, головокружение, потемнение в глазах, шум в ушах.

Бледность, холодный пот, падение давления, учащение пульса.

Алгоритм действий:

1. **Немедленно вызвать скорую.** Это состояние требует экстренной госпитализации в хирургическое отделение.
2. **Полный покой.** Уложите пострадавшего на спину, запретите двигаться и разговаривать.
3. **Холод на живот.** Положите пузырь со льдом на верхнюю часть живота (область желудка).
4. **Голод.** Категорически запрещено принимать пищу и воду! Желудок должен оставаться пустым. Допустимо только проглатывание мелких кусочков льда для утоления жажды (по назначению врача, но лучше ничего не давать).
5. **Наблюдение.** Следите за пульсом, давлением и сознанием до приезда бригады.

Вызов
скорой



Чего делать нельзя (Топ-5 грубых ошибок)

В экстренной ситуации легко поддаться панике и начать действовать во вред. Помните список того, что делать категорически запрещено при любых кровотечениях:

1. **Смазывать рану мазями, присыпками или народными средствами при сильном кровотечении.** Любая мазь создает жирную пленку, которая мешает образованию тромба, а присыпки загрязняют рану. В критической ситуации достаточно просто прижать сосуд или наложить чистую повязку.

2. **Извлекать инородный предмет из раны.** Если в ране торчит нож, стекло, щепка или любой другой предмет - **ни в коем случае не вынимайте его!** Он выполняет роль "затычки", сдавливая сосуд изнутри. Удалять инородное тело должны хирурги в операционной. Ваша задача - зафиксировать предмет (чтобы не болтался) и остановить кровотечение по краям раны давящей повязкой.
3. **Снимать жгут раньше времени.** Жгут - это крайняя мера. Но если уж вы его надели, помните про временные лимиты (лето - 60 минут, зима - 30). Раньше указанного времени снимать его нельзя, даже если кровь вроде бы остановилась, так как тромб может быть еще не сформирован. Если вам нужно ослабить жгут (например, при долгой транспортировке), делайте это, предварительно пережав артерию пальцем выше раны.
4. **Не утеплять конечность зимой после наложения жгута.** Кровообращение в конечности остановлено, она не получает тепла от крови. На морозе такая конечность очень быстро получает обморожение в дополнение к травме. Жгут необходимо утеплить (обмотать одеждой, шарфом, ватой).
5. **Игнорировать вызов скорой помощи.** Даже если вам удалось остановить кровь самостоятельно, пострадавший должен быть осмотрен врачом. Возможны инфицирование раны, постгеморрагическая анемия, а при внутреннем кровотечении - рецидив.

Когда необходима профессиональная медицинская помощь

Первая помощь - это лишь временная мера, призванная выиграть время до приезда квалифицированных специалистов. В большинстве случаев одной лишь давящей повязки или жгута недостаточно. Требуется профессиональная диагностика, хирургическая обработка раны, переливание крови или экстренная операция.

Жителям и гостям столицы важно знать, что в Москве существуют службы, готовые прийти на помощь в любое время. Если вам или вашим близким нужна не просто консультация, а гарантированная и быстрая транспортировка в стационар с полным медицинским сопровождением, вы можете обратиться в специализированную службу.

Когда ситуация выходит из-под контроля или требуется гарантированная транспортировка в стационар с полным медицинским сопровождением, на помощь приходят специализированные службы. В Москве одной из таких организаций является

МосМедТранс. Это не просто перевозка пациентов, а полноценная медицинская помощь на догоспитальном этапе. Компания работает на законных основаниях: имеет действующую лицензию на медицинскую деятельность, выданную еще в 2016 году, и аккредитацию города Москвы. Спектр разрешений впечатляет: от скорой помощи и реанимации до работы с педиатрическими пациентами и использования сильнодействующих веществ там, где это действительно необходимо.

Специалисты **МосМедТранс** - это команда из более чем 40 профессионалов: опытных фельдшеров, врачей скорой помощи и реаниматологов, которые ежедневно выезжают на вызовы. Автопарк компании насчитывает 10 полностью укомплектованных машин скорой помощи. Среди них есть настоящая "скорая на колесах" - реанимобиль, оснащенный по последнему слову техники для оказания помощи в самых критических ситуациях. Вся техника проходит регулярные проверки, а автомобили имеют официальную цветографическую окраску и звуковые сигналы, что позволяет им оперативно добираться до пациента в плотном городском трафике.

Важно и то, что **МосМедТранс** заботится не только о здоровье, но и о финансовых вопросах своих клиентов. Организация предоставляет полный пакет документов: договоры и чеки, которые принимают страховые компании для возмещения расходов, а также для оформления налогового вычета. Кроме того, у компании налажено взаимодействие с больницами Москвы и области: специальный отдел госпитализации помогает оперативно подобрать стационар и официально разместить пациента. Если вам нужна надежная скорая помощь, звоните по номеру **+7 (495) 150-05-33**

Заключение

Умение быстро и правильно остановить кровотечение - базовый навык выживания, который может потребоваться каждому. Подведем краткие итоги:

Капиллярное: достаточно промыть и наложить чистую повязку.

Венозное: тугая давящая повязка и возвышенное положение конечности.

Артериальное: пальцевое прижатие и жгут (строго с контролем времени!).

Внутреннее: холод, голод, покой и экстренная госпитализация.

Носовое: голова вперед, холод на переносицу, никакого запрокидывания.

Однако важно помнить золотое правило медицины: первая помощь - это не лечение, а лишь способ дотянуть до приезда профессионалов. Даже если вам удалось остановить кровь, пострадавший должен быть осмотрен врачом. Существуют риски инфицирования раны, развития постгеморрагической анемии или рецидива кровотечения, особенно при внутренних повреждениях.

В экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты, а состояние пациента вызывает серьезные опасения, не стоит полагаться только на свои силы. Своевременный вызов квалифицированной бригады скорой помощи - самое правильное и ответственное решение, которое может принять очевидец происшествия.

Список литературы

1. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения РФ. Протоколы оказания первой помощи при наружных кровотечениях. Москва, 2021.
2. Морозов В.И. "Первая помощь: учебник для водителей и спасателей". – М.: Медицина, 2020. – 320 с.
3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). "Руководство по оказанию первой помощи при травмах и кровотечениях". Женева, 2019.
4. Сумин С.А. "Неотложные состояния и скорая медицинская помощь". – М.: Медицинское информационное агентство, 2018. – 640 с.
5. Национальное общество скорой медицинской помощи. "Стандарты оснащения и алгоритмы действий при критических состояниях". Сборник методических рекомендаций, 2022.

< [Назад к списку](#)

Вызов
скорой



Остались вопросы?

Получите нашу бесплатную консультацию!

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Другие статьи

Как выбрать платную скорую помощь

**Лечение в клинике Хадасса Медикал
Москва (Hadassah): израильская
медицина в Сколково**

**Сердечный приступ (инфаркт
миокарда): как распознать, что делать
и как предотвратить**



mosmedtrans@mail.ru

г. Москва, Проспект 40 лет октября, д 5., стр. 2.



СЛУЖБА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

ИНН: 7731474111 / ОГРН: 1147746750018

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО41-01137-77/00307439 от
04.08.2016 года, выданная Департаментом здравоохранения города Москвы

Вызов
скорой

